

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Η βασική φιλοσοφία της *προνοσοκομειακής αντιμετώπισης του τραύματος*, έγκυται στην αλληλουχία της γρήγορης και ασφαλούς προσέγγισης, περισυλλογής, ακινητοποίησης και διακομιδής του τραυματία, το ταχύτερο δυνατό, σε πλησιέστερο κατάλληλο νοσοκομείο ή ειδικό κέντρο τραύματος, ενώ προηγουμένως - ή ακόμα και κατά τη μεταφορά του - έχει εξασφαλιστεί η αναζωογόνησή του και η κατά το δυνατόν σταθεροποίηση των ζωτικών σημείων, με τη λογική της προτεραιότητας και εφαρμογής συγκεκριμένων ενεργειών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, κατά τα γνωστά βήματα του ATLS (ή του PHTLS), δηλαδή τον κλασικό και παγκόσμιο αλγόριθμο «A, B, C, D, E» και τον δευτεροβάθμιο έλεγχο.

Φυσικά, όλη η αλληλουχία ενεργειών της ιατρονοσηλευτικής και διασωστικής ομάδας, που προσεγγίζει και περιθάλπει τον πολυτραυματία, εντάσσεται αυστηρά στο πλαίσιο του διαχρονικού ιπποκρατικού αφορισμού «*Ωφελείν ή μη βλάπτειν*» - «*First, do no harm*».

Όπως τονίστηκε στην αρχή του κεφαλαίου, στόχος είναι να επιτευχθεί η όσο το δυνατό *ταχεία και ασφαλής διακομιδή* του τραυματία στο χώρο της τελικής αντιμετώπισής του. Έχει παρατηρηθεί ότι εάν ο τραυματίας, ειδικά αυτός που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, δεν αντιμετωπισθεί χειρουργικά το πολύ σε διάστημα μίας ώρας από τη χρονική στιγμή του ατυχήματος, τότε οι πιθανότητες επιβίωσής του μειώνονται δραματικά. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η πρώτη ώρα μετά τον τραυματισμό χαρακτηρίστηκε από τον R Adams Cowley το 1963 σαν «*Χρυσή Ώρα*». Αυτό που έχει σημασία, είναι σαφώς, ότι όσο λιγότερο χρόνο – το μέγιστο 10-15 λεπτά – ξοδεύει ο ιατρός και οι διασώστες στο σημείο του συμβάντος, τόσο περισσότερο χρόνο μπορεί να κερδίσει και να διαθέσει η νοσοκομειακή ομάδα τραύματος στο ΤΕΠ, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον πολυτραυματία.

Παρ' όλα αυτά, πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι με τον όρο «*ταχεία διακομιδή*» του τραυματία σε **Κέντρο Τραύματος** δεν νοείται απλώς το «τσουβάλιασμα» του ασθενούς στο ασθενοφόρο και η ταχεία «αποκομιδή» από το σημείο του συμβάντος προς κάποιο ΤΕΠ! Η διακομιδή ενός πολυτραυματία – αλλά και οποιουδήποτε ασθενούς – είναι μια συνεχής «εν κινήσει» ιατρική και νοσηλευτική παρέμβαση, που απαιτεί ειδικές γνώσεις, δεξιότητες, ιδιαίτερη οξυδέρκεια και επαγρύπνηση από πλευράς ιατρού ή διασωστών που διακομίζουν. Και για να αποκτήσει νόημα ο όρος «Χρυσή Ώρα» θα πρέπει ο τραυματίας να φτάσει στο Κέντρο Τραύματος σταθεροποιημένος, έχοντας κερδίσει τις όποιες πιθανότητες επιβίωσης!

Εν κατακλείδι, η προσέγγιση στο πεδίο, η περισυλλογή, η αρχική εκτίμηση, ο έλεγχος της αιμορραγίας και κυρίως η αρχική αντιμετώπιση του πολυτραυματία είναι μία σταδιακή, αλλά παράλληλα συνεχής και δυναμικά εξελισσόμενη θεραπευτική διαδικασία, στην οποία το κάθε στάδιο έχει συγκεκριμένους στόχους, προτεραιότητες και αλληλουχία ενεργειών.

Πρώτο μέλημα αποτελεί η υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών, η αναζήτηση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και η άμεση αντιμετώπισή τους, η ακινητοποίηση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης κι ο έλεγχος της αιμορραγίας. Ειδικά, σε ό,τι αφορά στη χορήγηση υγρών και φαρμάκων σε προνοσοκομειακό επίπεδο, υπάρχει μεγάλη αντιγνωμία, με πρόσφατες μελέτες να θεωρούν ως βέλτιστο όγκο των χορηγούμενων υγρών τα 250-1250 ml κρυσταλλοειδών διαλυμάτων. [Deeb AP, et. al. “Optimal Prehospital Crystalloid Resuscitation Volume in Trauma Patients at Risk for Hemorrhagic Shock”. J Am Coll Surg. 2023.3.28].

Η εφαρμογή των σχετικών αλγορίθμων από το ιατρικό και το διασωστικό προσωπικό, εξειδικευμένο ή όχι, που έρχεται σε επαφή με το τραύμα, έχει ως αποτέλεσμα την ορθότερη προσέγγισή του σε κάθε βαθμίδα της ιατρικής περίθαλψης, την ταχεία και βασισμένη σε ενδείξεις παραπομπή των ασθενών σε κατάλληλα ειδικά κέντρα και τελικά, την καλύτερη παροχή ιατρικής φροντίδας, με τελική ευτυχή συνέπεια την καλύτερη αποκατάστασή τους.



ATLS
ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT

